

Higiena *snu*

W chorobie afektywnej dwubiegunowej sen nie jest sprawą wygody — to lek pierwszej linii. Każda noc bez snu zwiększa ryzyko epizodu manii w najbliższych dniach.

CZAS: codziennie 2 tygodnie do utrwalenia rytmu

ŹRÓDŁO: Wehr (1987); Plante & Winkelman (2008); Harvey i wsp. (2008)

JAK UŻYWAĆ

Trzymaj się **siedmiu zasad**: stała godzina wstawania (różnica maks. 30 min), stała godzina zaśnięcia, 7–9 godzin snu, żadnej drzemki dłuższej niż 30 min, ekspozycja na jasne światło rano przez 15–30 min, ciemność i chłód w sypialni, brak ekranów na godzinę przed snem. Jeśli śpisz mniej niż 6 godzin przez 2 noce — skontaktuj się z lekarzem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wehr (1987) udokumentował **klasyczny mechanizm**: deprywacja snu wywoływała manię u 30–70% pacjentów ChAD w warunkach kontrolowanych. Mechanizm dwukierunkowy: *mało snu prowadzi do manii*, ale też *nadchodząca mania zabiera potrzebę snu*. Sen jest jednocześnie wskaźnikiem stanu i czynnikiem modyfikującym chorobę. Stabilizatory nastroju (lit, walproinian, kwetiapina) zwiększają długość snu, ale to nie wystarczy — bez higieny snu sam lek nie utrzyma rytmu.

01 ⌚ Siedem zasad — protokół dla ChAD

1 · STAŁA GODZINA WSTANIA

Wybierz jedną godzinę, codziennie tę samą (różnica maks. **30 min**). Także w weekend. To kotwica całego rytmu — ważniejsza niż godzina zaśnięcia.

2 · STAŁA GODZINA ZAŚNIĘCIA

Cofnij się od godziny wstania o 8 godzin. Wprowadź *rytuał wieczorny* 30 min wcześniej: przyciemnione światło, książka lub muzyka.

3 · 7–9 GODZIN SNU

Poniżej 6 h = **czerwona flaga** (ryzyko manii).
Powyżej 10 h regularnie = możliwy prodrom depresji.

4 · DRZEMKA TYLKO KRÓTKA

Maks. 20–30 min, przed 15:00. Dłuższe drzemki zaburzają wieczorne zaśnięcie i przesuwają rytm.

5 · ŚWIATŁO RANO

15–30 min jasnego światła w pierwszej godzinie po przebudzeniu. Latem — okno, zima — lampa o natężeniu $\geq 10\,000$ luksów.

6 · CIEMNOŚĆ I CHŁÓD

Sypialnia: chłodno (18–19°C), ciemno (zasłony zaciemniające lub maska), cicho. Łóżko tylko do snu — nie pracuj w nim.

7 · BEZ EKRANÓW GODZINĘ PRZED SNEM

Telefon, laptop, tablet, telewizor — odkładasz *60 minut przed planowanym zaśnięciem*. Niebieskie światło hamuje melatoninę. Telefon poza sypialnią. Budzik — fizyczny, nie aplikacja.

02 ✕ Czego unikać

KOFEINA PO GODZ. 14

Kofeina ma okres półtrwania 5–6 godzin. Kawa o 16:00 = aktywny metabolit o 22:00. Też napoje energetyzujące i mocna herbata.

ALKOHOL WIECZOREM

Skraca fazę REM, fragmentuje sen. Wieczorny drink usypia, ale budzisz się o 3 nad ranem i nie zaśniesz. **Zwłaszcza ryzykowne w ChAD.**

PRACA ZMIANOWA

Nocne zmiany i zmienne godziny pracy *rozregulowują rytm dobowy*. Jeśli to możliwe — negocjuj stałe godziny. Jeśli nie — porozmawiaj z lekarzem o profilaktyce.

JET LAG

Podróże przez 3+ strefy czasowe to znany wyzwalacz manii. *Planuj z lekarzem*: lekka korekta dawki, melatonina, ograniczenie alkoholu w samolocie.

03 📅 Dziennik snu — 2 tygodnie

Wypełniaj rano po przebudzeniu. Po 14 dniach — porównaj z wykresem nastroju, szukając wzorca.

DZ.	ZASNAŁEM/- AM godz.	WSTAŁEM/- AM godz.	SEN godz.	JAKOŚĆ 0–10	CO PRZESZKADZAŁO / SPRZYJAŁO
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: Bauer i wsp. (2006) w prospektywnym badaniu 81 pacjentów ChAD wykazali, że *noc snu poniżej 3 godzin* wiązała się z 4,7-krotnie wyższym ryzykiem przejścia w manię w ciągu kolejnych 2 tygodni. Sen jest najczulszym znanym biomarkerem stanu — czulszym niż jakikolwiek kwestionariusz. Twój budzik o stałej godzinie to jedno z najtańszych i najskuteczniejszych narzędzi profilaktycznych, które masz.